

 Intensivpflege-Halle-GmbH	Notfallstandard Verdacht auf Thrombose	Qualitätshandbuch
		Geltungsbereich: Pflegefachkraft

Definition:

- Eine Thrombose wird durch ein Blutgerinnsel (sog. „Thrombus“) ausgelöst, das sich in einem Gefäß bildet. In der Folge wird das Gefäß ganz oder teilweise verschlossen.
- Abhängig von der Lokalisation des Thrombus wird zwischen einer arteriellen und einer venösen Thrombose unterschieden. Thrombosen im venösen Gefäßsystem treten deutlich häufiger auf.
- Eine Thrombophlebitis liegt vor, wenn oberflächliche Venen entzündet sind. Dieses ist zumeist die Folge eines Verschlusses in den oberflächlichen Beinvenen oder einer kleineren Verletzung bei bereits bestehenden Krampfadern. Eine Thrombophlebitis ist vergleichsweise harmlos, da sich ein Thrombus aufgrund der geringen Strömungsgeschwindigkeit zumeist nicht löst, sondern letztlich mit der Gefäßwand verwächst. Die Verstopfung im Gefäß wird durch Umgehungskreisläufe kompensiert. Die Störung heilt in den meisten Fällen komplikationsfrei ab.
- Ein hohes gesundheitliches Risiko hingegen geht von einer tiefen Beinvenenthrombose aus (sog. „Phlebothrombose“). Hier bildet sich ein Thrombus im Knie, im Oberschenkel oder im Becken. Wenn sich ein Gerinnsel löst, kann es durch den Blutstrom in die Lunge gelangen und dort eine Lungenembolie auslösen. **Es besteht dann Lebensgefahr!**
- Unter der sog. „Virchow-Trias“ werden die drei Hauptfaktoren bei der Entstehung einer Thrombose zusammengefasst:
 - Verlangsamte Blutströmung
 - Beschädigung der Gefäßwände
 - Gesteigerte Gerinnungsneigung

Grundsätze:

- Wenn hinreichende Anzeichen für eine Phlebothrombose bestehen, wird immer ein Notarzt gerufen. Die Folgen eines oder ggf. auch mehrerer Fehlalarme wiegen weniger schwer als eine verzögerte Behandlung bei einem echten Notfall!
- Der Notruf erfolgt auch dann, wenn der Bewohner diesen nicht wünscht, etwa weil er die Gefährdung nicht korrekt einschätzt.

1. Ziel:

- Eine Thrombose wird schnell und korrekt erkannt.
- Der Bewohner wird so schnell wie möglich medizinisch versorgt.
- Die gesundheitlichen Schäden einer Thrombose werden minimiert.

2. Anwendungsbereich:

Risikobewertung:

Wir überprüfen, welche Risikofaktoren bei dem Bewohner zutreffen.

- **Verlangsamte Blutströmung**

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	24.03.2023		1	1	Verw./MA

Zur besseren Lesbarkeit wird die männliche Form der Anrede genutzt. Selbstverständlich sind alle Geschlechter gemeint.

 Intensivpflege-Halle-GmbH	Notfallstandard Verdacht auf Thrombose	Qualitätshandbuch
		Geltungsbereich: Pflegefachkraft

- Bewegungsmangel
- Immobilität, etwa als Folge eines Schlaganfalls
- Gipsverband oder Schienenlagerung
- Schonhaltung als Folge starker und insbesondere chronischer Schmerzen
- Exsikkose, etwa als Folge von Durchfall oder Erbrechen
- Herzinsuffizienz
- Schock
- Chronische Veneninsuffizienz
- Krampfadern

• **Beschädigungen der Gefäßwände**

- Traumata jeder Art, also Verletzungen oder Quetschungen
- Operative Eingriffe, insbesondere Hüftgelenks-, Prostata-, Milz- oder Darmoperationen sowie Operationen in den unteren Extremitäten
- Degenerative Prozesse, also altersbedingter Umbau der Beinvenen, Varikosis usw.
- Entzündliche Prozesse, also etwa Venenentzündung (sog. „Phlebitis“)

• **Gesteigerte Gerinnungsneigung**

- Überhöhte Gerinnungsfaktoren im Blut, etwa als Folge von umfangreichen Operationen, gravierenden Verletzungen oder Verbrennungen.
- Einnahme von gerinnungsfördernden Arzneimitteln, etwa Kortison
- Hormonersatztherapie nach der Menopause
- angeborene Gerinnungsstörungen

• **weitere Risikofaktoren**

- Bewohner ist älter als 65 Jahre
- Fettreiche Ernährung, Adipositas
- Nikotinkonsum
- Bewohner erlitt in der Vergangenheit Thrombosen
- Schwere Infektionskrankheiten, insbesondere Sepsis
- Bösartige Tumorerkrankungen
- Herzinsuffizienz
- Lähmungen in den Extremitäten
- Vermehrte Urinausscheidung durch Einnahme entsprechende Medikamente (Diuretika)

Symptome:

Wir achten auf Symptome, die für eine Thrombophlebitis sprechen:

- Schmerzen entlang der betroffenen Venen oder im Bereich der Fußsohlen
- Überwärmung mit späterer Rötung und Schwellung im Bereich der betroffenen Extremität
- Anstieg der Pulsfrequenz und der Körpertemperatur

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	24.03.2023		1	2	Verw./MA

Zur besseren Lesbarkeit wird die männliche Form der Anrede genutzt. Selbstverständlich sind alle Geschlechter gemeint.

 Intensivpflege-Halle-GmbH	Notfallstandard Verdacht auf Thrombose	Qualitätshandbuch
		Geltungsbereich: Pflegefachkraft

- Bildung von Ödemen
- Die Venen sind verdickt und gerötet. Sie können unter der Haut deutlich ertastet werden.

Wir achten auf Symptome, die für eine tiefe Beinvenenthrombose sprechen:

- Waden reagieren empfindlich auf Druck (**sog. „Lowenberg-Zeichen“**)
- Schmerzen in der Wade, wenn der Fuß in Richtung Fußrücken gezogen wird
- Schmerzen in der Wade bei Fußstreckung (**sog. „Hohmann-Zeichen“**)
- Fußsohlen reagieren schmerzhaft auf Druck (**sog. „Payr-Zeichen“**)
- Schmerzen im Bein, wenn der Bewohner presst, hustet oder niest
- Schmerzen im Bein auch im Ruhezustand
- Schmerzen lassen bei Hochlagerung nach
- Schwere- und Spannungsgefühl im betroffenen Bein
- Betroffenes Bein ist wärmer als das nicht betroffene Bein (spürbar durch Handauflegen im direkten Vergleich beider Beine nebeneinander)
- Zyanose, also blaurote Verfärbung des Beines (sichtbar im direkten Vergleich beider Beine nebeneinander)
- Tachykardie, also deutlich erhöhte Pulsfrequenz
- Fieber, also Anstieg der Körpertemperatur auf über 38°C

Hinweise:

- Der Bewohner wird nach seiner Schmerzbelastung gefragt. Bei dementiell erkrankten Bewohnern achten wir auf nonverbale Schmerzäußerungen, insbesondere also Gestik und Mimik.
- Ein Druckschmerz zeigt sich meistens an folgenden Punkten:
 - Leiste
 - Oberschenkelinnenseite
 - Kniekehlen Bereich
 - Sog. „Meyer-Druckpunkte“ entlang der Vena saphena magna
 - Fußknöchelinnenseite (sog. „Kulissenschmerz“)
 - Fußsohle (Plantar Muskulatur)

3. Durchführung und Zuständigkeiten:

Maßnahmen bei Verdacht auf Thrombophlebitis:

- Der Bewohner wird zeitnah dem Hausarzt vorgestellt. Dieser entscheidet über die Therapie, etwa Bewegungsübungen oder Kompression.

Maßnahmen bei Verdacht auf Phlebothrombose:

- Bei jedem hinreichenden Verdacht auf eine Phlebothrombose wird unverzüglich der Notarzt informiert und eine Krankenhauseinweisung vorbereitet.
- Bis zum Eintreffen des Rettungsmediziners wird der Bewohner in sein Bett begleitet. Er soll strikte Bettruhe halten.

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	24.03.2023		1	3	Verw./MA

Zur besseren Lesbarkeit wird die männliche Form der Anrede genutzt. Selbstverständlich sind alle Geschlechter gemeint.

 Intensivpflege-Halle-GmbH	Notfallstandard Verdacht auf Thrombose	Qualitätshandbuch
		Geltungsbereich: Pflegefachkraft

- **Der Bewohner wird mit Nachdruck davon abgehalten, die Beine zu bewegen!**
- Es werden keine Bewegungsübungen durchgeführt.

Weitere Maßnahmen:

- Das Ereignis wird sorgfältig dokumentiert.
- Die Pflegedienstleitung wird umgehend informiert (falls noch nicht geschehen).
- Der Verlauf der Geschehnisse von den ersten Symptomen bis zum Eintreffen des Notarztes wird im Team noch einmal besprochen. Ziel ist es, ggf. aufgetretene Versäumnisse zu identifizieren.

Dokumentation:

Dokumentiert wird unter:

- Berichtblatt
- Ärztliche Kommunikation
- Ggf. Vitalwerte
- Pflegeüberleitungsbogen

Durchführungsverantwortung/ Qualifikation:

- Alle Pflegekräfte

Prozessverantwortlichkeit:

- Pflegedienstleitung, QMB stellv. PDL, Wohnbereichsleitung

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	24.03.2023		1	4	Verw./MA

Zur besseren Lesbarkeit wird die männliche Form der Anrede genutzt. Selbstverständlich sind alle Geschlechter gemeint.